



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 30 — Parada Cardiorrespiratória: Suporte Básico e Avançado de Vida (adulto, com notas pediátricas e situações especiais)

Reconhecimento, RCP de alta qualidade, desfibrilação, adrenalina e antiarrítmicos, via aérea, causas reversíveis (H's e T's), cuidados pós-PCR, critérios de interrupção e comunicação — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-30	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A sobrevida na PCR depende de quatro coisas que não exigem tecnologia: **reconhecer em 10 segundos, comprimir bem e sem pausas, desfibrilar cedo e procurar a causa**. Este protocolo padroniza o "código azul" institucional do PS Natal Diegues — papéis, carrinho, sequência, fármacos e o que fazer nos primeiros 60 minutos após o retorno da circulação até a transferência para UTI. Vale para qualquer setor (sala de emergência, observação, sala de vacina, estacionamento).

Fontes de ancoragem: American Heart Association. 2025 Guidelines for CPR and Emergency Cardiovascular Care — Adult Basic and Advanced Life Support, Pediatric BLS/ALS, Post-Cardiac Arrest Care, Special Circumstances (Circulation 2025;152(Suppl 2), out/2025) [AHA 2025]; AHA 2020 Guidelines (Panchal AR, et al. Circulation 2020;142:S366; Topjian AA, et al. S469) para itens mantidos [AHA 2020]; ILCOR 2023 CoSTR; **Bernoché C, Timerman S, Polastri TF, et al. Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019**. Arq Bras Cardiol 2019;113(3):449-663 [SBC-RCP 2019]; Nolan JP, et al. ERC/ESICM post-resuscitation care guidelines 2021. Resuscitation 2021;161:220 [ERC 2021]; Resolução CFM nº 1.805/2006 e 2.156/2016 (limitação terapêutica, diretivas), Resolução CFM nº 1.995/2012 (diretivas antecipadas); Portaria GM/MS nº 2.048/2002.

Convenção de confiança: doses seguem AHA 2025/2020 e SBC 2019; pediátricas conferidas com PALS e sujeitas ao dose lock. **[VERIFICAR]:** desfibrilador bifásico com pás adesivas e marca-passo, capnografia, acesso intraósseo, carrinho por setor, escala de treinamento BLS/ACLS da equipe.

1. Reconhecimento — os primeiros 10 segundos

Passo	Ação
Segurança e resposta	Cena segura; chamar "Senhor(a), está me ouvindo?" com toque nos ombros
Sem resposta → acionar o código	Gritar por ajuda; acionar o código azul institucional (campanha/ramal ____ [VERIFICAR]); pedir o carrinho e o desfibrilador
Checar respiração e pulso simultaneamente por ≤10 s	Pulso carotídeo (femoral se não palpável; braquial em lactente); gaspings não é respiração . Sem pulso ou dúvida → iniciar compressões. Pulso presente sem respiração → 1 ventilação a cada 6 s (adulto) / 2–3 s (criança) e reavaliar a cada 2 min; opioide? → naloxona
Posição	Superfície rígida (prancha), decúbito dorsal, tórax exposto
Gestante ≥20 semanas	Deslocamento uterino manual para a esquerda desde o início; preparar cesariana perimortem (seção 7.4)

Ritmos de parada

Chocáveis: fibrilação ventricular (FV) e taquicardia ventricular sem pulso (TVSP) — a única terapia definitiva é o choque; cada minuto sem desfibrilar reduz a sobrevida em 7–10%. **Não chocáveis:** assistolia (confirmar em 2 derivações, ganho e cabos — "protocolo da linha reta") e atividade elétrica sem pulso (AESP — ritmo organizado sem pulso; pensar em causa reversível). Ritmo pode mudar a cada checagem: tratar o que se vê a cada 2 minutos.

2. RCP de alta qualidade — o que não se negocia [AHA 2025/2020; SBC 2019]

Componente	Adulto	Criança (1 ano-puberdade)	Lactente (<1 ano)
Frequência	100–120/min	100–120/min	100–120/min
Profundidade	5–6 cm	1/3 do diâmetro AP (~5 cm)	1/3 do diâmetro AP (~4 cm)
Técnica	Duas mãos, metade inferior do esterno, braços estendidos	Uma ou duas mãos	Dois polegares com mãos envolvendo o tórax (2 socorristas) ou 2 dedos
Retorno do tórax	Completo a cada compressão (não apoiar)	Idem	Idem
Relação compressão:ventilação sem via aérea avançada	30:2	30:2 (1 socorrista) / 15:2 (2 socorristas)	30:2 / 15:2
Com via aérea avançada	Compressões contínuas + 1 ventilação a cada 6 s (10/min)	Contínuas + 1 ventilação a cada 2–3 s (20–30/min)	Idem
Interrupções	<10 s ; fração de compressão >80%; trocar compressor a cada 2 min (ou antes se cansaço)	Idem	Idem
Ventilação	1 s cada, volume suficiente para elevar o tórax; evitar hiperventilação ; O ₂ a 100% durante a RCP	Idem	Idem
Monitorização	Capnografia (ETCO₂) : alvo ≥10 mmHg, ideal ≥20 — se <10, melhorar compressões; salto abrupto = RCE; PA diastólica >25 mmHg se linha arterial	Idem	Idem

Dispositivos mecânicos de compressão: sem benefício de sobrevida (PARAMEDIC, LINC) — não são padrão; RCP com cabeceira elevada: não fora de pesquisa (AHA 2025). Compressões torácicas só (sem ventilação) são aceitáveis para leigos, não para a equipe do PS.

3. Desfibrilação [AHA 2025]

Item	Conduta
Quando	FV/TVSP: choque imediato assim que o desfibrilador chegar (compressões até carregar); minimizar pausa pré e pós-choque (<5 s); retomar compressões imediatamente após o choque sem checar pulso
Energia (bifásico)	1º choque: dose recomendada pelo fabricante (120–200 J) ; se desconhecida, máxima ; choques subsequentes: igual ou escalonada (2b) — na dúvida, máxima. Monofásico: 360 J. Criança: 2 J/kg → 4 J/kg → ≥4 J/kg (máx. 10 J/kg ou dose adulta)
Estratégia	Choque único seguido de 2 min de RCP (não "empilhar" choques); checar ritmo/pulso só a cada 2 min
Pás	Adesivas preferíveis (permitem marca-passo e menos pausa); posição ântero-lateral (esterno direito/ápice) ou anteroposterior; secar o tórax, retirar adesivos de nitrato, afastar O ₂
FV persistente após ≥3 choques	Verificar técnica (contato, posição, energia, qualidade da RCP, K/Mg, isquemia); mudança de vetor (pás AP) ou desfibrilação dupla sequencial "podem ser consideradas" (AHA 2025: utilidade não estabelecida, 2b — usar como resgate, um operador acionando em sequência); antiarrítmico (7.2); lembrar que 80% das "refratárias" são recorrências — tratar a causa
DEA	Em setores sem desfibrilador manual: ligar, seguir as instruções, pás pediátricas <8 anos/25 kg (se ausentes, usar adulto)
Marca-passo na PCR	Não usar marca-passo (transcutâneo/transvenoso) em assistolia/AESP (AHA 2025: sem benefício)

4. Via aérea e acesso vascular

Item	Conduta
Via aérea inicial	Bolsa-válvula-máscara com O₂ a 100% e cânula orofaríngea é suficiente na fase inicial; técnica de 2 pessoas (vedação com duas mãos); elevar o queixo/tração de mandíbula; aspirar
Via aérea avançada	Não interromper compressões para intubar : adiar a IOT até falha das primeiras tentativas de RCP/desfibrilação ou RCE (AHA 2025, classe I); dispositivo supraglótico (máscara laríngea) é alternativa aceitável e mais rápida se a equipe não intuba com frequência; IOT por quem tem experiência/retreino, em ≤10 s de pausa (idealmente sem pausa, com videolaringoscópio)
Confirmação	Capnografia de onda contínua (padrão-ouro) + ausculta; sem ETCO ₂ detectável → reintubar/ver posição; fixar; após via aérea avançada: 1 ventilação/6 s
Acesso vascular	IV periférico primeiro (classe I); se falha ou inviável em ≤90 s → intraósseo (tíbia proximal/úmero; 2a); central só por profissional treinado se IV/IO falharem; flush de 20 mL após cada droga com elevação do membro
Via traqueal	Não recomendada (absorção errática); só em ausência total de acesso — adrenalina 2–2,5× a dose em 10 mL
O ₂ e ventilação	FiO ₂ máxima durante a RCP; após RCE, titular (seção 8)

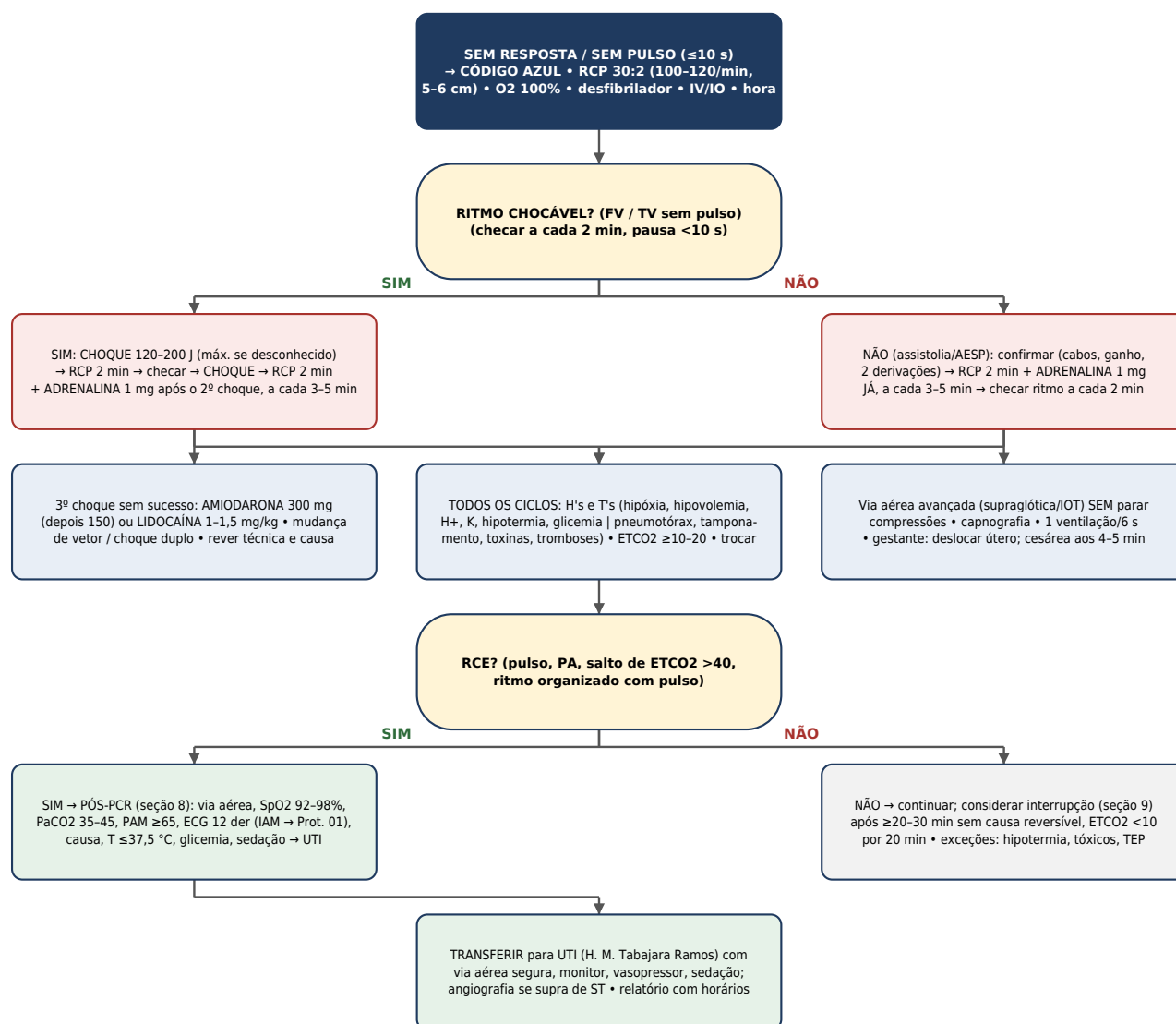
5. Causas reversíveis — H's e T's (buscar desde o 1º ciclo, sobretudo em AESP/assistolia)

H	Pistas e tratamento	T	Pistas e tratamento
Hipóxia	Via aérea obstruída, afogamento, asma/DPOC — ventilar/oxigenar; corpo estranho	Tensão (pneumotórax hipertensivo)	Trauma, VM, asma, DPOC; MV abolido, desvio de traqueia, distensão jugular — descompressão com agulha (2º EIC linha hemiclavicular ou 4º-5º EIC linha axilar anterior) → dreno
Hipovolemia	Hemorragia (trauma, HDA, aneurisma, gravidez ectópica), desidratação, sepse — cristalóide 1-2 L rápido, sangue O negativo/tipagem, controle da fonte	Tamponament o cardíaco	Trauma, dissecação, pericardite, neoplasia, DRC; POCUS — pericardiocentese (subxifoide, guiada) / toracotomia na referência
Hidrogênio (acidose)	DRC, intoxicação (tricíclico, salicilato, metformina), PCR prolongada — bicarbonato só se indicação específica (hiperK, tricíclico, acidose pré-existente grave); não de rotina	Toxinas	Opioide (naloxona 0,4-2 mg IV/IM/IN, repetir), tricíclico (bicarbonato 1-2 mEq/kg), BB/BCC (cálcio, glucagon, insulina alta dose), digoxina (Fab), organofosforado (atropina), cocaína (BZD, bicarbonato), anestésico local (emulsão lipídica 1,5 mL/kg) — Protocolo 23; RCP prolongada justificada
Hipo/hipercalémia (e hipoglicemia, hipocalcemia)	HiperK: DRC, ondas T apiculadas, QRS largo — gluconato de cálcio 10% 10-30 mL IV + insulina 10 U + glicose 50% + bicarbonato 50 mEq + salbutamol; hipoK: KCl 10-20 mEq IV com MgSO ₄ 2 g; glicemia capilar em toda PCR (hipoglicemia: glicose 50% 40 mL)	Trombose coronária	IAM — a causa mais comum de FV no adulto; após RCE, ECG 12 derivações → Protocolo 01 (angiografia urgente se supra; fibrinólise se transferência impossível e sem contraindicação)
Hipotermia	T <30 °C: RCP prolongada, adiar drogas e limitar a 1 choque até >30 °C, reaquecimento ativo ("ninguém está morto até estar quente e morto")	Trombose pulmonar (TEP)	Suspeita forte (TVP, imobilização, câncer, VD dilatado ao POCUS, AESP com QRS estreito): fibrinólise (alteplase 50 mg IV em bólus, repetir em 15 min se necessário; ou tenecteplase por peso) e continuar RCP por 60-90 min

POCUS durante a PCR (VD dilatado, tamponamento, pneumotórax, hipovolemia, atividade cardíaca) só se não interromper as compressões — realizar na pausa de checagem de ritmo por ≤10 s, com o exame gravado (AHA 2025: utilidade diagnóstica não bem estabelecida; não usar para prognosticar).

6. Fluxo de atendimento — algoritmo integrado [AHA 2025, adaptado]

Cada ciclo dura **2 minutos**. A cada checagem: ritmo → chocável? → choque ou não → RCP → droga → causa. O líder fala em voz alta, um registrador anota horários, um responsável pelo desfibrilador, um pela via aérea, dois compressores alternando.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Papéis no código azul (mínimo de 4 pessoas; ideal 6)

Papel	Responsabilidades
Líder (médico)	Posição aos pés do leito; decide ritmo/choque/drogas/causa; comunica em alça fechada; não comprime nem intuba se houver equipe
Compressor 1 e 2	Alternam a cada 2 min (ou antes); qualidade guiada por ETCO ₂ /feedback
Via aérea	BVM com O ₂ , cânula, aspiração; supraglótico/IOT quando indicado; capnografia
Desfibrilador/monitor	Pás adesivas, análise de ritmo, carga durante compressões, choque em ≤5 s de pausa; marca-passo e cardioversão pós-RCE
Drogas/acesso	IV/IO, adrenalina no relógio (3–5 min), antiarrítmico, flush; checa doses em voz alta
Registrador/cronômetro	Hora da PCR, de cada choque/droga/ritmo, ETCO ₂ ; avisa "2 minutos" e "adrenalina em 1 min"; preenche o formulário de PCR (Utstein)
Apoio à família	Presença familiar durante a RCP é permitida e recomendada se houver quem acompanhe e explique (AHA/ERC)

7. Fármacos e situações especiais

7.1 Vasopressor [AHA 2025]

Fármaco	Dose	Momento	Observações
Adrenalina (1 mg/mL)	1 mg IV/IO a cada 3-5 min (criança 0,01 mg/kg = 0,1 mL/kg da diluição 1:10.000; máx. 1 mg)	Não chocável: o mais cedo possível (1º ciclo). Chocável: após falha dos choques iniciais (após o 2º choque)	Flush 20 mL; não usar dose alta; vasopressina (isolada ou associada) não substitui; corticoide durante a PCR: benefício incerto — não de rotina

7.2 Antiarrítmicos e outros [AHA 2025]

Fármaco	Dose	Indicação	Observações
Amiodarona	300 mg IV/IO em bólus (diluir em 20 mL SG 5%) → 2ª dose 150 mg após 3-5 min; criança 5 mg/kg (repetir até 3x)	FV/TVSP persistente após 3º choque + adrenalina (2b)	Após RCE: infusão 1 mg/min 6 h → 0,5 mg/min 18 h se TV/FV recorrente
Lidocaína	1-1,5 mg/kg IV/IO → 0,5-0,75 mg/kg a cada 5-10 min (máx. 3 mg/kg); criança 1 mg/kg	Alternativa equivalente à amiodarona	Infusão 1-4 mg/min após RCE se usada
Sulfato de magnésio	1-2 g IV/IO em 10 mL (criança 25-50 mg/kg, máx. 2 g)	Só torsades de pointes / hipomagnesemia	Não de rotina (classe III)
Bicarbonato de sódio 8,4%	1 mEq/kg (50-100 mL)	Só hiperK , intoxicação por tricíclico/salicilato/cocaína, acidose grave pré-existente	Não de rotina (classe III); piora acidose intracelular
Gluconato de cálcio 10%	10-30 mL IV/IO (cloreto de cálcio 10% 5-10 mL)	Só hiperK , hipocalcemia, intoxicação por BCC, hipermagnesemia, transfusão maciça	Não de rotina (classe III)
Naloxona	0,4-2 mg IV/IO/IM/IN, repetir a cada 2-3 min	Suspeita de opioide (miose, agulhas, frascos) — não atrasa RCP/adrenalina	Em PCR confirmada, o benefício é incerto; útil na parada respiratória com pulso
Fibrinolítico	Alteplase 50 mg IV bólus (repetir 50 mg em 15 min) ou tenecteplase 0,5 mg/kg (máx. 50 mg)	TEP suspeito/confirmado como causa; IAM com supra se ICP impossível e RCE não obtido é controverso	Manter RCP 60-90 min após o bólus
Glicose 50%	40 mL IV (criança G10% 2-5 mL/kg)	Hipoglicemia documentada	Glicemia capilar em toda PCR
Emulsão lipídica 20%	1,5 mL/kg bólus + 0,25 mL/kg/min	Intoxicação por anestésico local (bupivacaína); tricíclico refratário (opção)	Referência/toxicologia

7.3 Pediatria — pontos que diferem do adulto [PALS / AHA 2025]

- Causa mais comum é hipóxia/asfixia: **ventilação é prioritária**; com pulso e sem respiração: 1 ventilação a cada 2-3 s; RCP 15:2 com 2 socorristas.
- Desfibrilação: 2 J/kg → 4 J/kg → ≥4 J/kg (máx. 10 J/kg); pás pediátricas <8 anos/25 kg; adrenalina 0,01 mg/kg (1:10.000, 0,1 mL/kg) a cada 3-5 min; amiodarona 5 mg/kg ou lidocaína 1 mg/kg.
- Acesso IO precoce (tíbia proximal) se IV não obtido em 1-2 tentativas; fita de Broselow para peso/doses/tubos [VERIFICAR fita e material pediátrico no carrinho].
- Bradicardia <60 com má perfusão apesar de oxigenação/ventilação = iniciar compressões; atropina 0,02 mg/kg (mín. 0,1 mg) se tônus vagal/BAV.
- Pós-RCE: evitar febre (≤37,5 °C por 72 h) e hipotensão (PAS >5º percentil para a idade); SpO₂ 94-99%; normocapnia; glicemia; transferir para UTI pediátrica (Santa Casa de Mogi Guaçu / referência).

7.4 Situações especiais [AHA 2025/2020; SBC 2019]

Situação	Conduta específica
Gestante (≥20 semanas / fundo uterino ≥ cicatriz umbilical)	Deslocamento uterino manual para a esquerda contínuo; compressões e choques padrão (energia igual); via aérea precoce (edema, aspiração); acesso acima do diafragma; cesariana perimortem (histerotomia de ressuscitação) aos 4 min de PCR sem RCE, com nascimento aos 5 min — no local, com bisturi, sem transportar; causas: hemorragia, embolia amniótica, eclâmpsia/MgSO ₄ (gluconato de cálcio), anestesia, cardiomiopatia periparto, TEP; acionar obstetrícia/neonatologia (Santa Casa) desde o início
Afogamento	Ventilação prioritária (5 ventilações iniciais); RCP padrão; hipotermia associada; não tentar retirar água; aspiração; O ₂ ; internar todo afogado com sintomas
Hipotermia (<30–32 °C)	RCP prolongada; 1 choque e sem drogas até T >30 °C (intervalo dobrado entre 30–35 °C); reaquecimento ativo (cobertores térmicos, soro aquecido 40–42 °C, ar aquecido); ECMO na referência
Hipercalemia	Cálcio + insulina/glicose + bicarbonato + salbutamol (Protocolo 24); RCP prolongada; diálise pós-RCE
Intoxicações	Protocolo 23; RCP prolongada (até horas) e ECMO em tóxicos com pulso ausente e causa reversível
Trauma	Controle de hemorragia (torniquete, compressão), descompressão bilateral de tórax, volume/sangue, toracotomia de ressuscitação só em centro de trauma com indicação (<15 min de PCR presenciada penetrante); AESP em trauma = hipovolemia/tamponamento/pneumotórax até prova em contrário
Anafilaxia	Adrenalina IM/IV, volume agressivo (4–8 L), RCP prolongada (Protocolo 12)
Asma grave	Descompressão de pneumotórax; desconectar do ventilador e comprimir o tórax (auto-PEEP); RCP padrão
Após cirurgia cardíaca / marca-passo / CDI	Referência; ímã sobre CDI se choques inapropriados

8. Cuidados pós-PCR — primeiros 60 minutos até a transferência [AHA 2025; ERC 2021]

Domínio	Alvo / conduta
Via aérea e ventilação	IOT se não feita e Glasgow ≤ 8 ; capnografia; SpO₂ 92-98% (evitar hiperóxia — reduzir FiO ₂ assim que houver oximetria confiável); PaCO₂ 35-45 mmHg ; VC 6-8 mL/kg; RX de tórax ²
Hemodinâmica	PAS ≥ 90 / PAM ≥ 65 mmHg ; cristalóide 1-2 L se hipovolemia; noradrenalina 0,05-0,5 mcg/kg/min $\pm$ dobutamina se disfunção miocárdica pós-PCR (frequente e transitória); tratar arritmias (Protocolo 18); ECG 12 derivações imediatamente
Coronária	Supra de ST ou suspeita forte de IAM → angiografia urgente (regular Hospital Municipal Tabajara Ramos — hemodinâmica); sem supra: angiografia não urgente de rotina (COACT/TOMAHAWK), decisão da referência; fibrinólise se transferência impossível (Protocolo 01)
Neurológico	Se não obedece comandos: controle direcionado de temperatura — manter 32-37,5 °C com prevenção ativa de febre (>37,5 °C) por $\geq 36-72$ h (AHA 2025/ILCOR 2023 — hipotermia a 33 °C não é mais obrigatória; escolher a meta pactuada com a UTI); sedação/analgesia (propofol/midazolam + fentanil); tratar convulsão/mioclonia (levetiracetam/valproato — não profilaxia); cabeceira 30°; EEG na UTI
Metabólico	Glicemia 140-180 mg/dL (insulina se >180; evitar hipoglicemia); Na, K (4-4,5), Mg, Ca, lactato, gasometria, troponina, hemograma, creatinina, TGO/TGP, coagulograma, culturas se sepse suspeita
Causa	Completar H's e T's: TC de crânio se causa neurológica suspeita ou sem explicação cardíaca (transferir); angio-TC se TEP; toxicologia; ecocardiograma
Prognóstico	Não prognosticar antes de 72 h do RCE (após normotermia e sem sedação); nenhum sinal isolado nas primeiras horas (pupilas, mioclonia, Glasgow) justifica limitação — comunicar isso à família e à referência
Transferência	Toda PCR com RCE vai para UTI (Hospital Municipal Tabajara Ramos; pediatria/obstetrícia → Santa Casa de Mogi Guaçu): via aérea segura, monitor, vasopressor em bomba, sedação, pás adesivas mantidas, sonda gástrica/vesical, relatório com hora da PCR, ritmo inicial, tempo até 1º choque/adrenalina, nº de choques, drogas, hora do RCE, ETCO₂, ECG pós, exames, causa presumida, temperatura e diretivas se houver

9. Quando não iniciar, quando interromper e como comunicar

Situação	Conduta
Não iniciar RCP	Sinais evidentes de morte (rigidez, livores, decomposição, lesões incompatíveis com a vida); diretiva antecipada de vontade ou ordem de não reanimar documentada (Res. CFM 1.995/2012; 1.805/2006) em paciente com doença terminal em cuidados paliativos; decisão registrada previamente em prontuário pela equipe com paciente/família. Na dúvida, iniciar
Interromper a RCP (decisão do líder, multimodal, registrada)	Após $\geq 20-30$ min de ACLS de qualidade sem RCE, com: assistolia persistente, ausência de causa reversível tratável, ETCO₂ <10 mmHg após 20 min em paciente intubado (AHA 2025, 2b — como parte da decisão, não isolado), PCR não presenciada sem RCP por leigos, comorbidade terminal. Não interromper precocemente em: hipotermia, intoxicação, TEP com fibrinólise feita, afogamento em água fria, jovem/criança, gestante, FV persistente/recorrente, RCE intermitente
Hora do óbito	Registrar hora da constatação, ritmo final, duração da RCP; declaração de óbito pelo médico assistente se causa natural conhecida; causa externa/violenta/desconhecida → IML/SVO e comunicação à autoridade policial; morte materna/infantil/fetal → notificação e comitê
Comunicação com a família	Local reservado, sentados, sem pressa; protocolo SPIKES; linguagem clara ("morreu", não eufemismos); permitir presença junto ao corpo; explicar próximos passos (documentos, IML, funerária); ofertar apoio (psicologia, serviço social, assistência religiosa); registrar quem foi informado e por quem
Doação de órgãos/tecidos	Óbito no PS: notificar a Central de Transplantes (córneas/tecidos — até 6 h) conforme fluxo da OPO regional [VERIFICAR]; morte encefálica não é diagnosticada no PS sem UTI — transferir se RCE com suspeita
Debriefing da equipe	Após todo código (5-10 min): o que funcionou, o que falhou, reposição do carrinho, registro Utstein; apoio emocional; revisão mensal de indicadores

10. Estrutura, treinamento e indicadores

10.1 Carrinho de emergência (checklist diário lacrado) [VERIFICAR itens contra a lista institucional]

Gaveta / item	Conteúdo mínimo
Desfibrilador	Bifásico com monitor, pás adesivas adulto/pediátricas, pás manuais + gel, marca-passo transcutâneo, bateria carregada, papel; DEA nos setores remotos
Via aérea	BVM adulto/ pediátrica/ neonatal com reservatório, máscaras, cânulas de Guedel (todos os tamanhos), laringoscópio (lâminas retas e curvas, pilhas extras) ± videolaringoscópio, tubos 2,5–8,5 com guia, máscaras laríngeas nº 1–5, aspirador com sondas, capnógrafo, fixador de tubo, cricotireoidostomia (kit ou agulha 14G + tubo 6,0)
Acesso	Jelcos 14–24G, agulha/kit intraósseo (adulto e pediátrico), seringas, equipos, SF 0,9%/Ringer 500 mL x6, torneiras, garrote
Drogas	Adrenalina 1 mg x20, amiodarona 150 mg x6, lidocaína 2% x4, atropina 0,5 mg x10, bicarbonato 8,4% x4, gluconato de cálcio 10% x4, MgSO ₄ 50% x4, glicose 50% x6, naloxona x4, flumazenil x2, midazolam x6, fentanil x4, cetamina x2, succinilcolina/rocurônio, noradrenalina x6, dopamina x4, dobutamina x2, adenosina x4, metoprolol IV x2, hidrocortisona x2, salbutamol spray, insulina regular, alteplase/tenecteplase (na farmácia, acesso em ≤10 min), emulsão lipídica 20% 500 mL
Outros	Prancha rígida, luvas, máscaras N95, óculos, lanterna, tesoura, eletrodos, fita de Broselow, formulário de PCR/Utstein, algoritmos plastificados (adulto/ pediátrico/ gestante), relógio visível, esfigmomanômetro, glicosímetro, bisturi (cesariana perimortem)

10.2 Treinamento

- BLS anual para 100% da equipe (inclusive administrativos e recepção — a primeira compressão é de quem está perto); ACLS/PALS a cada 2 anos para médicos e enfermeiros da emergência; simulação in situ trimestral com debriefing (código azul em setores diferentes, cesariana perimortem, hipercalcemia, criança).
- Sinalização do código (ramal/campainha) conhecida por todos; carrinho lacrado com checklist diário assinado; desfibrilador testado a cada plantão.

10.3 Indicadores de qualidade (auditoria mensal — registro Utstein)

Indicador	Meta
% de PCR com hora de reconhecimento, ritmo inicial, tempo até 1ª compressão e até 1º choque registrados	100%
Tempo reconhecimento → 1ª compressão / → 1º choque (FV/TVSP)	≤1 min / ≤3 min
% de FV/TVSP com adrenalina após o 2º choque (não antes) e amiodarona/lidocaína após o 3º	≥90%
% de assistolia/AESP com adrenalina no 1º ciclo e H's/T's documentados	≥90%
Uso rotineiro de bicarbonato/cálcio/magnésio sem indicação; marca-passo em assistolia (eventos sentinela)	0
% de RCE com ECG 12 der, SpO ₂ 92–98%, PAM ≥65, temperatura e glicemia documentados na 1ª hora	≥90%
% de RCE transferidos para UTI com relatório completo	100%
% de códigos com debriefing e carrinho repostado em ≤1 h	≥90%
Taxa de RCE, sobrevida à alta e desfecho neurológico (via referência)	Registrar
Checklist diário do carrinho e teste do desfibrilador	100% dos dias

11. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Momento da adrenalina na FV	AHA 2020/2025: após falha dos choques iniciais (após o 2º); SBC 2019: após o 2º choque; ERC: após o 3º. Adotado após o 2º
Energia escalonada x fixa	AHA 2025: conforme fabricante; escalonar é razoável (2b). Adotado: 1º choque conforme fabricante ou máximo; escalonar depois
Mudança de vetor / choque duplo	ILCOR 2023: "pode ser considerado"; AHA 2025: utilidade não estabelecida (2b). Adotado como resgate após ≥3 choques, com técnica revisada antes
Bicarbonato, cálcio, magnésio	AHA 2025: classe III (sem benefício) de rotina — só com indicação específica. SBC 2019 semelhante. Adotado
Via aérea avançada	AHA 2025: adiar até falha inicial/RCE; supraglótico aceitável. SBC 2019: IOT quando possível sem interromper. Adotada a AHA
Temperatura pós-PCR	AHA 2020: 32–36 °C por ≥24 h; ILCOR 2023/AHA 2025/ERC 2021: 32–37,5 °C com prevenção de febre; TTM2 sem diferença entre 33 e 36. Adotado: evitar febre (≤37,5 °C) ≥36–72 h e meta pactuada com a UTI
Angiografia pós-RCE sem supra	COACT/TOMAHAWK: sem benefício de rotina; decisão da referência
ETCO ₂ <10 para interromper	AHA 2025: parte de decisão multimodal (2b), nunca isolado. Adotado
Cesariana perimortem aos 4 min	AHA/SBC/FEBRASGO convergentes; exige bisturi no carrinho e equipe treinada — acionar obstetrícia da Santa Casa por telefone durante a RCP [VERIFICAR]
Capnografia, IO, pás adesivas, videolaringoscópio	Equipamentos que definem a qualidade do ACLS [VERIFICAR/ADQUIRIR]

12. Referências

- American Heart Association. 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation* 2025;152(Suppl 2) — Adult Basic and Advanced Life Support; Pediatric Basic and Advanced Life Support; Post-Cardiac Arrest Care; Resuscitation in Special Circumstances (Executive Summary, out/2025).
- Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 AHA Guidelines. *Circulation* 2020;142(16 Suppl 2):S366-S468. Topjian AA, et al. Part 4: Pediatric Basic and Advanced Life Support. *Circulation* 2020;142:S469-S523.
- Bernoche C, Timerman S, Polastri TF, et al. Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. *Arq Bras Cardiol* 2019;113(3):449-663.
- Nolan JP, Sandroni C, Böttiger BW, et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine guidelines 2021: post-resuscitation care. *Resuscitation* 2021;161:220-269. Wyckoff MH, et al. 2023 International Consensus on CPR and ECC Science With Treatment Recommendations (ILCOR CoSTR). *Circulation* 2023;148:e187.
- Cheskes S, Verbeek PR, Drennan IR, et al. Defibrillation strategies for refractory ventricular fibrillation (DOSE-VF). *N Engl J Med* 2022;387:1947-1956. Dankiewicz J, et al. Hypothermia versus normothermia after out-of-hospital cardiac arrest (TTM2). *N Engl J Med* 2021;384:2283-2294. Lemkes JS, et al. Coronary angiography after cardiac arrest without ST-segment elevation (COACT). *N Engl J Med* 2019;380:1397-1407. Desch S, et al. (TOMAHAWK). *N Engl J Med* 2021;385:2544-2553. Perkins GD, et al. (PARAMEDIC). *Lancet* 2015;385:947-955.
- Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.805/2006; Resolução CFM nº 1.995/2012 (diretivas antecipadas de vontade); Resolução CFM nº 2.156/2016 (admissão em UTI). Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.048/2002. Lei nº 9.434/1997 (transplantes).
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de parada cardiorrespiratória (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração